

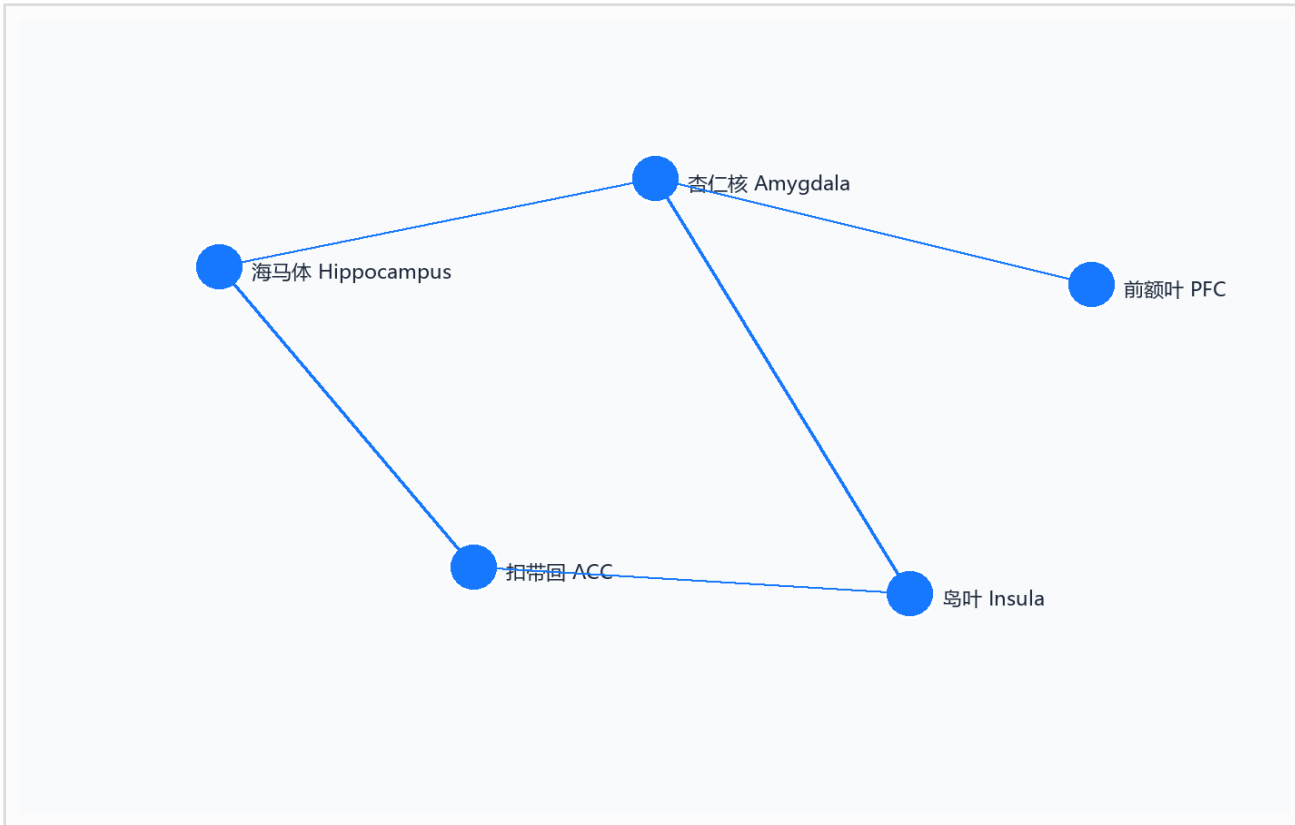
脑部健康分析报告

基于 NeuroGraphIQ 知识图谱回路分析

一、临床分析

患者表现为**记忆减退**与**注意力下降**，伴随轻度焦虑与睡眠碎片化。结合知识图谱匹配结果，提示海马、杏仁核与前额叶相关回路参与度较高，症状呈现认知-情绪双重受累特征。

二、大脑回路分析



上图展示了系统匹配的核心神经回路连接关系：节点表示脑区，连线表示神经投射通路。

系统优先匹配到海马-杏仁核情绪记忆回路，以及前额叶执行控制通路。正常情况下，海马负责情景记忆编码，杏仁核标记情绪显著性，前额叶完成注意分配与行为抑制；当上述通路协调失衡时，可出现记忆提取困难与情绪易激惹。

- 海马体：情景记忆编码与检索
 - 杏仁核：情绪显著性与威胁评估
 - 前额叶：执行控制、工作记忆与注意切换
 - 扣带回/岛叶：冲突监测与内感受整合
- 首发记忆症状与海马相关投射高度一致
 - 焦虑波动可能与杏仁核-前额叶调节减弱有关
 - 建议结合临床表现进一步验证回路解释

三、神经递质与脑电活动

多巴胺与去甲肾上腺素系统可能参与注意调节；睡眠相关慢波活动不足可加重日间认知波动。报告仅提供机制参考，不替代脑电或实验室诊断。

四、循环系统与脑脊液

需关注脑灌注与代谢负荷。若存在慢性失眠与应激，可能通过自主神经张力升高间接影响脑血流自我调节，建议临床按需完善相关评估。

五、外周器官与神经影响

自主神经张力升高可加重焦虑与睡眠问题；肠道-脑轴与心血管负荷也可能反馈放大症状波动，建议同步关注生活方式与外周共病。

六、综合总结与建议

综合来看，当前症状更符合认知-情绪相关回路功能失衡的解释框架。建议完善神经心理评估，优化睡眠与应激管理，并与临床医生讨论是否需要进一步影像或电生理检查。本报告为知识图谱辅助参考，不能作为医疗诊断依据。